

Meningite bacteriana no adulto - porta

Suspeita de meningite bacteriana: hemoculturas + antibiótico empírico sem demora. A LP confirma, mas não atrasa o tratamento se houver sinal de alarme ou atraso de imagem.

Quando TC antes da LP

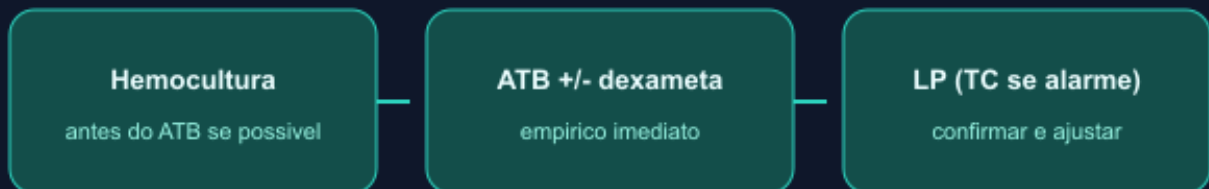
Lembre - Quando TC antes da LP

Imunocomprometido, história de SNC, papiledema, déficit focal, convulsão recente ou rebaixamento grave — faça TC antes da LP, mas não atrase ATB.

Ordem que a prova ama: estabilizar e tratar primeiro; depois documentar LCR quando seguro.

Meningite suspeita

ABC -> ATB -> LP / TC



Empírico clássico (adulto)

- Cefalosporina 3ª (ceftriaxona/cefotaxima) + vancomicina (pneumococo resistente)
- Ampicilina se risco de Listeria (>50 anos, gestante, imunossuprimido, álcool)
- Dexametasona antes ou com a 1ª dose de ATB (benefício no pneumococo)
- Isolamento gotículas até 24 h de ATB eficaz (meningococo)

LCR — padrões

Tipo | Células | Glicose / proteína

Bacteriana | PMN !!! | Glicose !"/>proteína !"

Viral | Linfó !' | Glicose N / proteína ±

TB/fungo | Linfó !' | Glicose !"/>proteína !'!"

Listeria | Pode ter linfó | Pensar no contexto

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Nunca atrase antibiótico esperando TC/LP em meningite fulminante. Profilaxia de contatos no meningococo (rifampicina/cipro/ceftriaxona) conforme protocolo — item clássico.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Tríade clínica, contraindicações à punção e timing do corticoide definem a conduta na meningite bacteriana do adulto.

Febre + rigidez de nuca + alteração mental — mas a tríade completa é incompleta em muitos casos.

Triade e red flags

Suspeita clínica

- 1 Febre
- 2 Rigidez de nuca
- 3 Alteração do estado mental
- 4 Cefaleia / fotofobia / vômitos
- 5 Purpura / petéquias (N. meningitidis)

Cefaleia e vômitos são comuns; petéquias → meningococo

Não atrasar antibiótico se punção/TC forem demorar.

Sequência na emergência

Hemocultura → ATB → imagem? → LCR

1. Hemoculturas + dexametasona
2. Antibiótico empírico imediato
3. TC se indicada → punção lombar

Contraindicações / TC antes da PL

Indicação de TC pré-PL | Exemplos

Sinais de hipertensão IC / massa | papiledema, déficit focal, convulsão recente
Imunossupressão grave | HIV avançado, transplantado
Rebaixamento marcado | Glasgow baixo / coma
História de SNC | neoplasia, cirurgia, AVC recente

ATB empírico adulto (ideia comunitária)

- Ceftriaxona/cefotaxima + vancomicina (cobertura pneumococo resistente)
- Ampicilina se >50 anos / alcoolismo / imunossupressão (Listeria)
- Dexametasona: idealmente antes ou com a 1ª dose de ATB; manter se pneumococo
- Isolamento gotículas se meningococo até 24 h de ATB

LCR bacteriano típico

Lembre - LCR bacteriano típico

Pressão !, celularidade ! (PMN), proteínas !, glicose !, bacterioscopia/cultura ± PCR.

Timing do corticoide

Atencao - Timing do corticoide

Dexametasona 10 mg IV q6h (adulto) — iniciar com o ATB; benefício mais claro no pneumococo (reduz mortalidade/sequela).

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.
www.medhubr1.com.br - MedHub R1